

Avaliação pré-operatória · risco e jejum

Pré-operatório bem feito reduz cancelamento e evento CV. Estime risco do paciente × risco do procedimento; peça exames só se mudarem conduta.

Risco cardíaco

Dica - Risco cardíaco

Procedimento de risco alto + fatores clínicos (DAC, IC, DM, IRC, AVC) !' avaliação adicional.

Emergência opera com otimização possível — não atrase trauma/peritonite por 'check-up completo'.

Organize: otimizar comorbidades !' suspender/manter drogas !' jejum !' ATB na indução.



Drogas e jejum

- Manter betabloqueador e estatina se já em uso crônico (em geral)
- IECA/BRA: muitos protocolos suspendem no dia (hipotensão anestésica)
- Metformina: suspender em risco de hipoperfusão/contraste — evitar acidose láctica
- Jejum: 8/6 h sólidos (conforme guia) e 2 h líquidos claros

Profilaxia antimicrobiana

Cirurgia | Exemplo clássico

Limpa com prótese | Cefazolina

Digestiva alta/baixa | Cobertura anaeróbia conforme sítio

Via biliar | Cefazolina ± Gram"

Alergia grave a beta-lactâmico | Clinda ± vancomicina / protocolo

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

ATB profilática deve estar na pele antes da incisão (janela ~60 min; vancomicina mais cedo). Dose única costuma bastar — não 'prolonge 7 dias' sem infecção.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Avaliação pré-operatória: ASA Physical Status resume reserva fisiológica e comunica risco — memorize I–VI.

ASA não sozinho cancela cirurgia — comunica comorbidade. Emergent (E) adiciona urgência ao status.

ASA Physical Status

Classificação de risco anestesiológico

ASA I - saudável, sem doença sistêmica	I
ASA II - doença sistêmica leve	II
ASA III - doença sistêmica grave	III
ASA IV - ameaça constante à vida	IV
ASA V - moribundo, sem cirurgia pode morrer	V
ASA VI - morte encefálica (doação de órgãos)	VI

I sadio | II sistêmica leve | III grave | IV ameaça constante | V moribundo | VI morte encefálica

Exemplos clássicos

ASA | Exemplos de prova

- I | Jovem saudável, sem comorbidades
- II | HAS controlada, DM controlado, obesidade leve, tabagista
- III | DM com lesão de órgão, DPOC limitante, ICC compensada, IAM antigo
- IV | ICC descompensada, IAM recente, sepse, IRA grave
- V | Ruptura de aneurisma com choque, trauma devastador
- VI | Morte encefálica — captação de órgãos

Checklist pré-op útil

- Jejum, vias aéreas, alergias, anticoagulantes/antiagregantes
- Otimizar HAS, glicemia, anemia e infecção quando eletivo
- Risco cardíaco: capacidade funcional (METs) + tipo de cirurgia
- Trombopprofilaxia e antibioticoprofilaxia no timing correto

Emergência

Lembre - Emergência

Em cirurgia de urgência/emergência, não atrase o salva-vidas por 'liberação clínica' completa — estabilize o possível e documente risco (ASA + E).

Prova

Dica - Prova

ASA II vs III: a diferença é doença sistêmica leve/controlada versus grave com limitação funcional ou lesão de órgão.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1